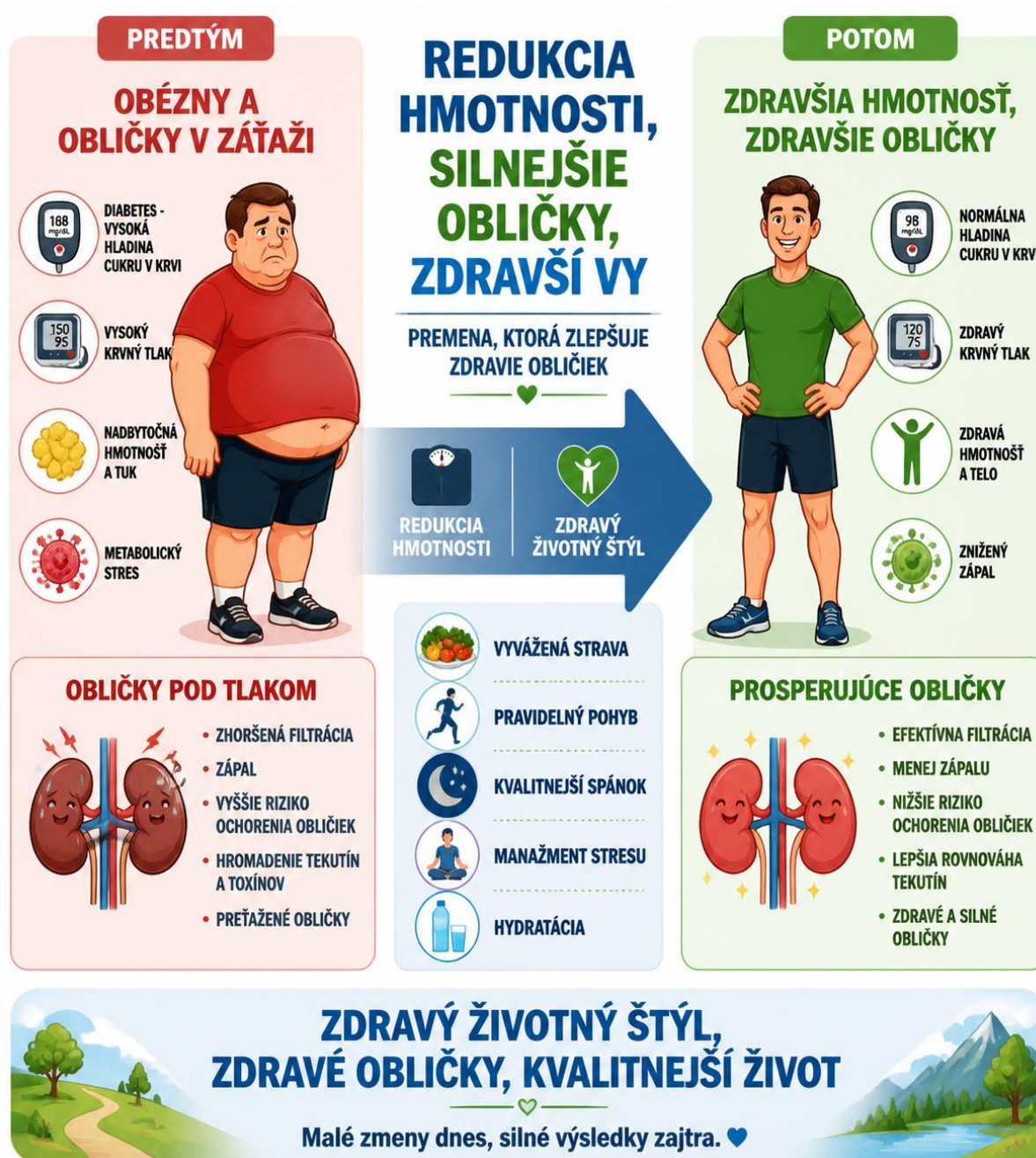


Obezita a obličky

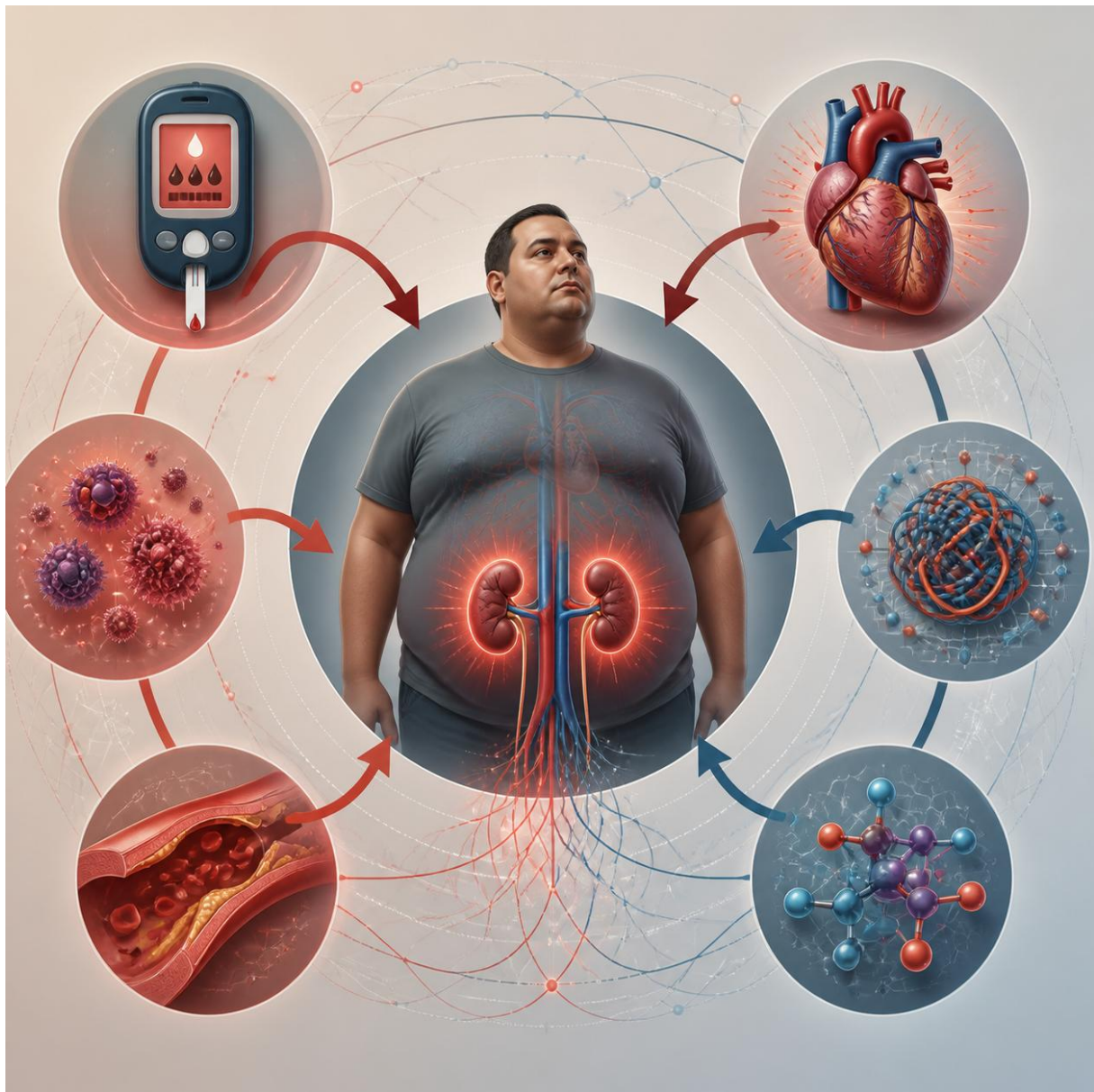
Ako redukcia hmotnosti u diabetika odľahčí filtračný aparát obličiek a aké sú súčasné medicínske možnosti manažmentu obezity

MUDr. Ľubomír Polaščin
Nefrológ a internista



Keď má človek diabetes a zároveň aj obezitu, nejde len o „dva problémy vedľa seba“. Ide o jeden spoločný príbeh, v ktorom sa stretávajú metabolická nerovnováha, zmeny v cievach, zápalové procesy a často aj zhoršená schopnosť dlhodobo udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi. Obezita v takomto prostredí zvyšuje nároky na organizmus a postupne sa môže premietnuť aj do toho, ako fungujú obličky.

Obličky sú pri diabetikovi „tichými svedkami“ dlhodobého stresu. Nemusia bolieť, neukážu sa hneď v plnom rozsahu a človek môže roky fungovať tak, že sa nič dramatické „nevníma“. Napriek tomu sa v pozadí môžu diať zmeny, ktoré sa neskôr prejavia albumínom v moči, postupným zhoršovaním funkcie obličiek a zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom. Preto medzinárodné odporúčania zdôrazňujú, že pri diabete a chronickom ochorení obličiek ide o komplexný manažment rizík vrátane tlaku, albuminúrie a celkového kardiometabolického zdravia, nie iba o glykémiu [1,2].

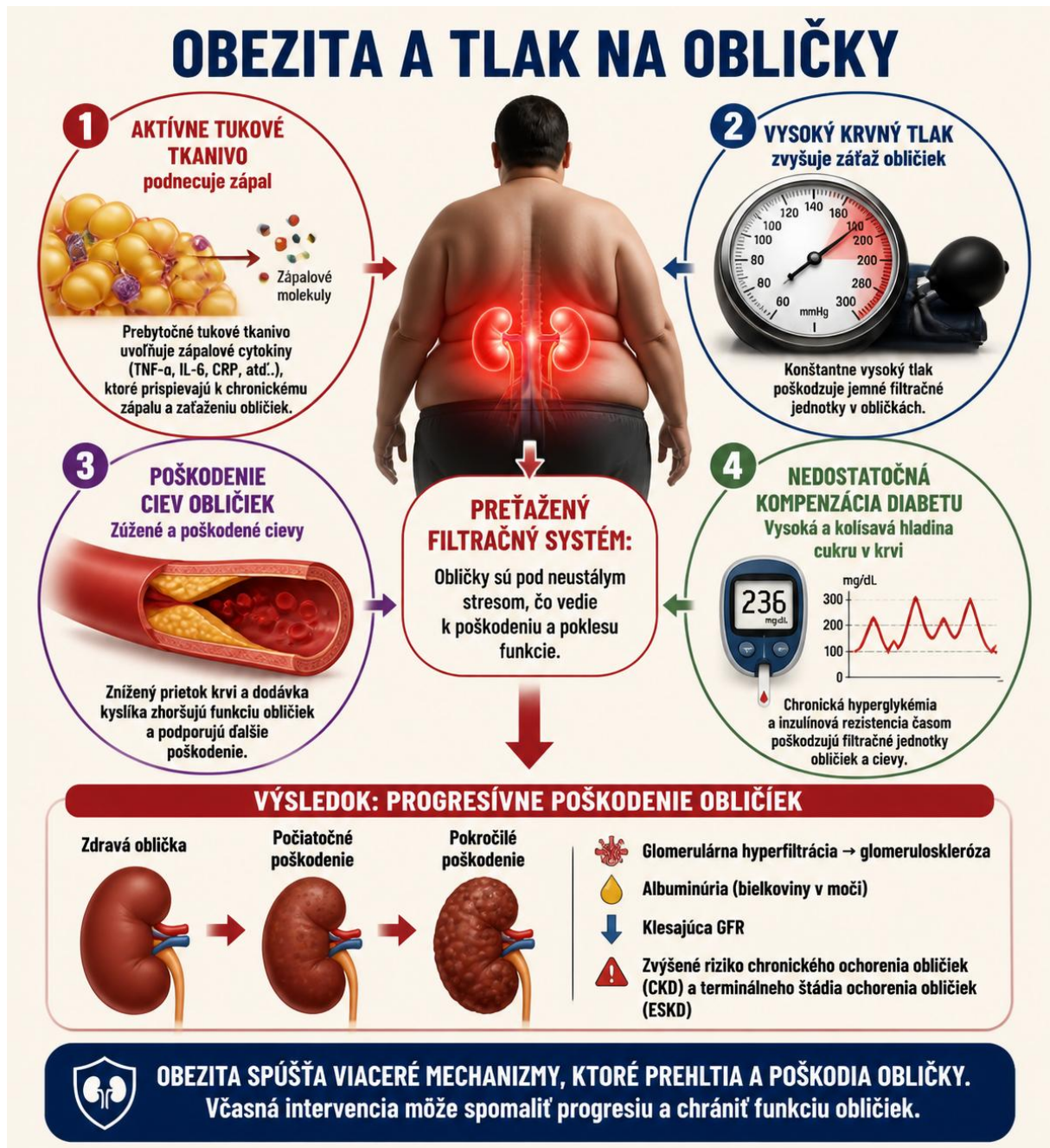


Prečo obezita zvyšuje tlak na obličky

V praxi je užitočné predstaviť si obličku ako filtračný systém, ktorý potrebuje stabilné podmienky. Pri obezite sa často mení viac vecí naraz. Tukové tkanivo nie je len „sklad energie“. Je aktívne a vytvára látky a signály, ktoré podporujú chronický zápal, zhoršujú inzulínovú citlivosť a súvisia aj s poruchami metabolizmu tukov. To isté sa týka aj faktorov, ktoré zvyšujú riziko poškodenia ciev a tým aj cievnych štruktúr v obličkách.

K tomu sa pridáva častý sprievodný problém: vysoký krvný tlak. Aj keď sa o krvnom tlaku hovorí často, pri obličkách platí, že ide o jedného z najdôležitejších „spúšťačov“ dlhodobého poškodenia filtračného aparátu. Ak je tlak dlhodobo vyšší, oblička sa musí prispôbiť. Ak je adaptácia dlhodobá a nevhodná, zvyšuje sa riziko, že sa poškodenie časom zafixuje. Medzinárodné dokumenty pre manažment diabetu pri chronickom ochorení obličiek preto opakovane zdôrazňujú, že treba pracovať aj s tlakom, albuminúriou a celkovým kardiometabolickým rizikom, nie iba s jedným „číslom“ [1,2].

Obezita navyše často zhoršuje kvalitu kompenzácie diabetu. Človek môže byť na liečbe, ale inzulínová rezistencia zostáva vysoká, hladiny cukru sa môžu opakovane „tlačiť“ hore a potom opäť klesať a tento kolotoč metabolického stresu postupne zasahuje orgány. Keď sa tento proces kombinuje s už spomenutými tlakmi a zápalom, obraz sa zhoršuje aj pre obličky. A preto dáva zmysel, že redukcia hmotnosti sa v modernej medicíne nepovažuje za kozmetický cieľ, ale môže byť súčasťou ochrany orgánov [1,2].



Ako môže redukcia hmotnosti u diabetika odľahčiť filtračný aparát

Najdôležitejšie je, že chudnutie môže ovplyvniť viac mechanizmov naraz. Nie vždy sa to dá vysvetliť jednou vetou a nie u každého bude mať rovnaký účinok. V praxi sa však často pozoruje, že keď sa dlhodobo zlepši metabolická situácia, spravidla sa zlepši aj prostredie pre obličky.

Pri redukcii hmotnosti často nastane aspoň časť týchto javov: znižuje sa inzulínová rezistencia, lepšie sa regulujú výkyvy glykémie, postupne sa zlepšuje krvný tlak a znižuje

sa chronický zápalový signál. Tým sa menia „podmienky v okolí“ obličky. Ak sú tieto podmienky menej stresujúce, obličky nemusia tak intenzívne kompenzovať a riziko progresie poškodenia sa môže znížiť. Práve albuminúria je v tomto kontexte dôležitým signálom. Ak sa albumín v moči znižuje, často to znamená, že sa zlepšujú podmienky pre filtračný aparát [1,2].

Bezpečný a koordinovaný prístup k redukcii hmotnosti je kľúčový na to, aby sa pacienti cítili istí, že ich zdravie je v dobrých rukách a že riziká sú minimalizované.

Je reálne chudnúť a pritom neublížiť obličkám? Áno, ale nie je to automatické. Preto je vhodné vyhnúť sa jednoduchým sľubom typu „schudnete a obličky sa hneď opravia“. Také tvrdenie by bolo pre pacientov zavádzajúce. Rozumnejšia formulácia znie: správne vedená a postupná redukcia hmotnosti môže znížiť riziká, odľahčiť organizmus a podporiť priaznivejší priebeh ochorenia vrátane ochorení obličiek.

Podstatné je, že pri diabetikovi s rizikom ochorenia obličiek sa sleduje viacero parametrov. Zvyčajne ide o funkciu obličiek, prítomnosť albumínu v moči, krvný tlak a dlhodobú kontrolu glykémie. Pri sledovaní týchto ukazovateľov je možné prispôbiť liečbu tak, aby bola bezpečná a aby chudnutie nebolo spojené s nepriaznivými vedľajšími účinkami. Tento prístup je v súlade s medzinárodnými odporúčaniami, ktoré zdôrazňujú individualizáciu a manažment rizík [1,2].

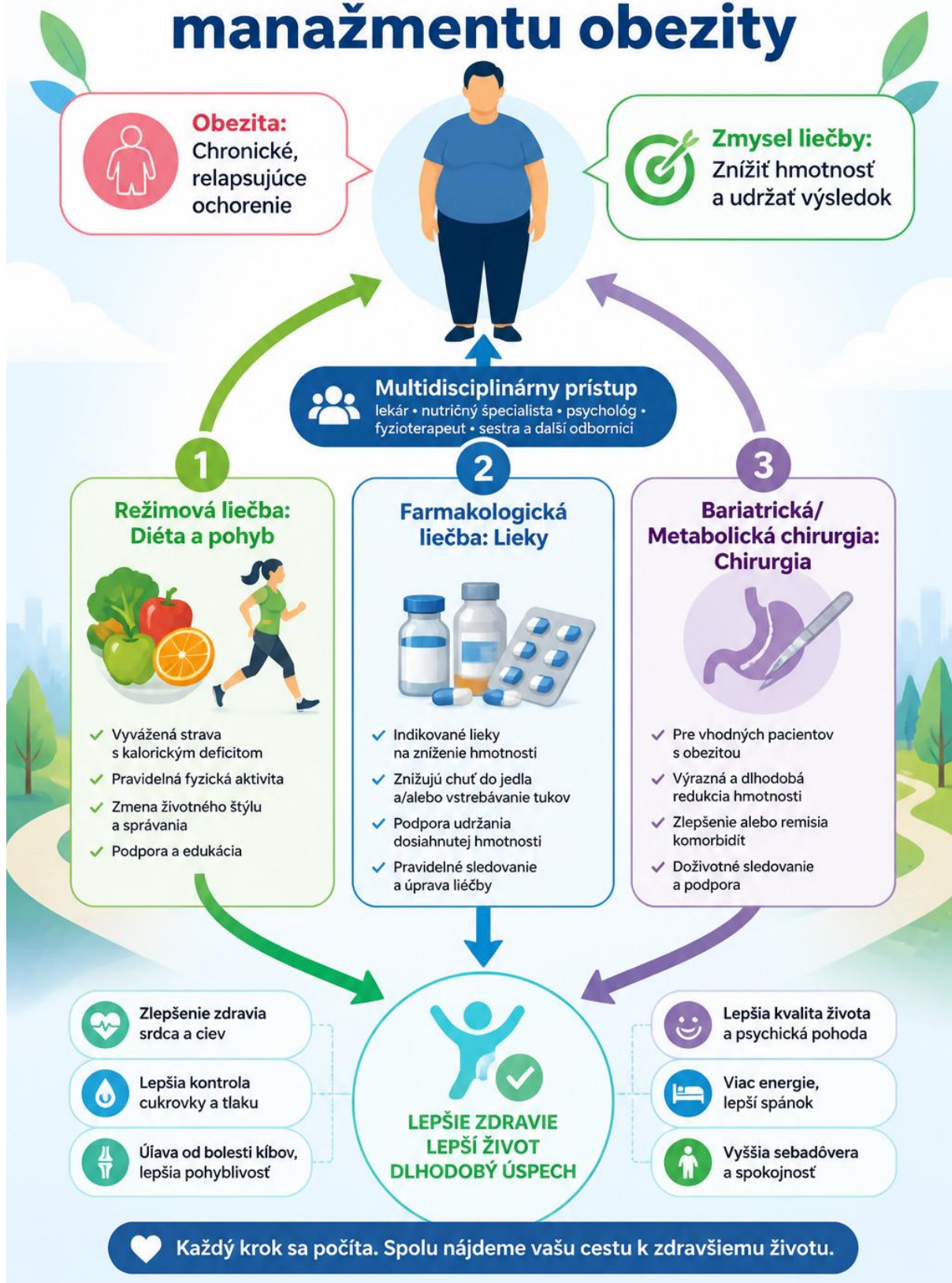


Súčasný medicínske možnosti manažmentu obezity

Dnes už nikto neberie obezitu len ako „nedostatok vôle“. V medicíne sa obezita chápe ako chronické, relapsujúce ochorenie, ktoré si často vyžaduje dlhodobý plán. Zmyslom liečby je znížiť hmotnosť a najmä udržať dosiahnutý výsledok, aby sa znížilo riziko komplikácií. Na Slovensku štandardné postupy aj odborné dokumenty zdôrazňujú multidisciplinárny prístup, edukáciu a spoluprácu viacerých odborov [5].

V praxi sa liečba zvyčajne skladá z troch rovín. Prvá je režimová: strava je nastavená tak, aby podporovala lepšiu metabolickú kontrolu a primeraný pohyb podľa možností človeka. Druhá je farmakologická, keď samotné režimové opatrenia nestačia alebo ich nie je možné dosiahnuť v požadovanom čase a rozsahu. Tretia rovina je bariatrická alebo metabolická chirurgia u vybraných pacientov, kde môže byť prínos výrazný, ale vždy je potrebné zvážiť indikácie a následné sledovanie [5].

Súčasné medicínske možnosti manažmentu obezity



Farmakoterapia, ktorá mení hru (aj pri diabetikovi)

Jedným z významných posunov posledných rokov je širšie využívanie liečby, ktorá pôsobí na mechanizmy spojené s reguláciou chuti do jedla a energetického metabolizmu.

Príkladom sú lieky na báze semaglutidu, ktoré sa v rôznych odporúčaniach uvádzajú ako možnosť manažmentu nadváhy a obezity u vhodných pacientov spolu so zníženou kalorickou diétou a zvýšenou fyzickou aktivitou [3].

V klinických štúdiách semaglutid viedol k významnej redukcii hmotnosti u dospelých s nadváhou alebo obezitou a výsledky patria medzi dôvody, prečo sa lieková liečba v praxi stala bežnou súčasťou manažmentu obezity v mnohých krajinách [4]. Pre diabetikov je dôležité, aby sa takáto liečba posudzovala v kontexte celej terapie diabetu a obličiek. Nie je to jedno univerzálne riešenie, ale nástroj, ktorý môže zmysluplne doplniť režim, ak je indikovaný a bezpečný pre konkrétneho človeka [1,2,7].

Zároveň platí, že lieky nie sú náhradou za zmeny životného štýlu. Skôr pomáhajú prekonať biologické brzdy, ktoré sa objavajú, keď človek začne žiť v kalorickom deficite a telo sa snaží vrátiť do pôvodného stavu. Keď je farmakoterapia správne načasovaná a koordinovaná, zvyšuje sa šanca, že výsledok bude trvalý [3,4,9].

Farmakoterapia obezity: Nová éra v liečbe

PREDTÝM

- VYŠŠIA HMOTNOSŤ
- VYŠŠIE RIZIKO DIABETU 2. TYPU
- VYŠŠIE RIZIKO KARDIO-VASKULÁRNYCH OCHORENÍ
- ZVÝŠENÉ ZATAŽENIE KLBOV

POTOM

- NIŽŠIA HMOTNOSŤ
- LEPŠIA KONTROLA GLYKÉMIE
- NIŽŠIE KARDIO-VASKULÁRNE RIZIKO
- MEŇŠIE ZATAŽENIE KLBOV

Působí na reguláciu chuti do jedla a energetického metabolizmu.

1 VÝRAZNÁ REDUKCIA HMOTNOSTI

2 PODPORA PRI DODRŽIAVANÍ ZMIEN ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

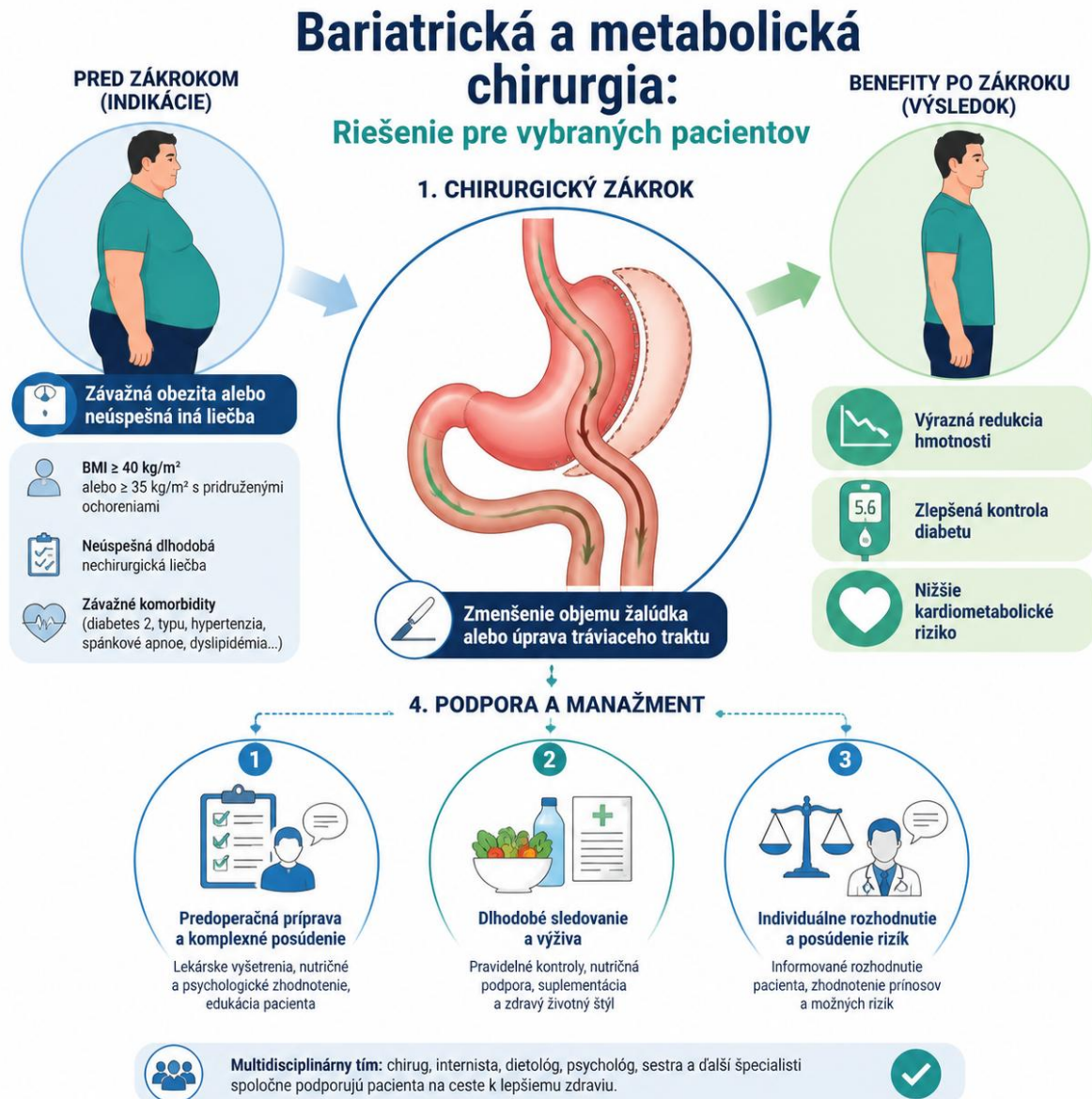
3 ZLEPŠENIE METABOLICKÝCH PARAMETROV (GLYKÉMIA, OBLIČKY)

! NIE náhrada životného štýlu, ale účinný nástroj.

Kľúč k dlhodobému úspechu v manažmente obezity a diabetu.

Chirurgia, keď je to medicínsky odôvodnené

Bariatrická a metabolická chirurgia môže byť veľmi účinná u vybraných pacientov so závažnou obezitou alebo u tých, u ktorých iné možnosti neposkytujú udržateľné výsledky. V odporúčaní sa zdôrazňuje, že ide o liečbu s prípravou, sledovaním a dlhodobým nutričným manažmentom. Pri diabetikovi môže mať výrazný metabolický dopad, ale rozhodnutie musí byť individuálne, s ohľadom na komorbidity a riziká [5,9].



Čo by mal pacient riešiť s lekárom pri diabete a obezite (prakticky)

Ak chcete, aby redukcia hmotnosti chránila aj obličky, je dobré mať v hlave jednoduchú logiku: cieľ nie je „schudnúť“, ale znížiť riziko komplikácií a spomaliť poškodenie orgánov. A k tomu patrí aj pravidelná kontrola.

Pri konzultácii má zmysel pýtať sa na trend albuminúrie a funkcie obličiek, na krvný tlak a na to, ako sa nastaví diabetologická liečba tak, aby sa pri redukcii neznížila bezpečnosť pacienta. Dôležité je aj to, aký typ režimu a pohybového plánu je vhodný, aby sa minimalizovalo riziko zníženia svalovej hmoty a zachovala sa výkonnosť. Ak je indikovaná farmakoterapia obezity, treba zvážiť jej bezpečnosť v kontexte obličiek a diabetu. Tento

typ koordinovaného tímového prístupu zodpovedá odporúčaniam manažmentu diabetu a obličiek aj v medzinárodných dokumentoch [1,2].

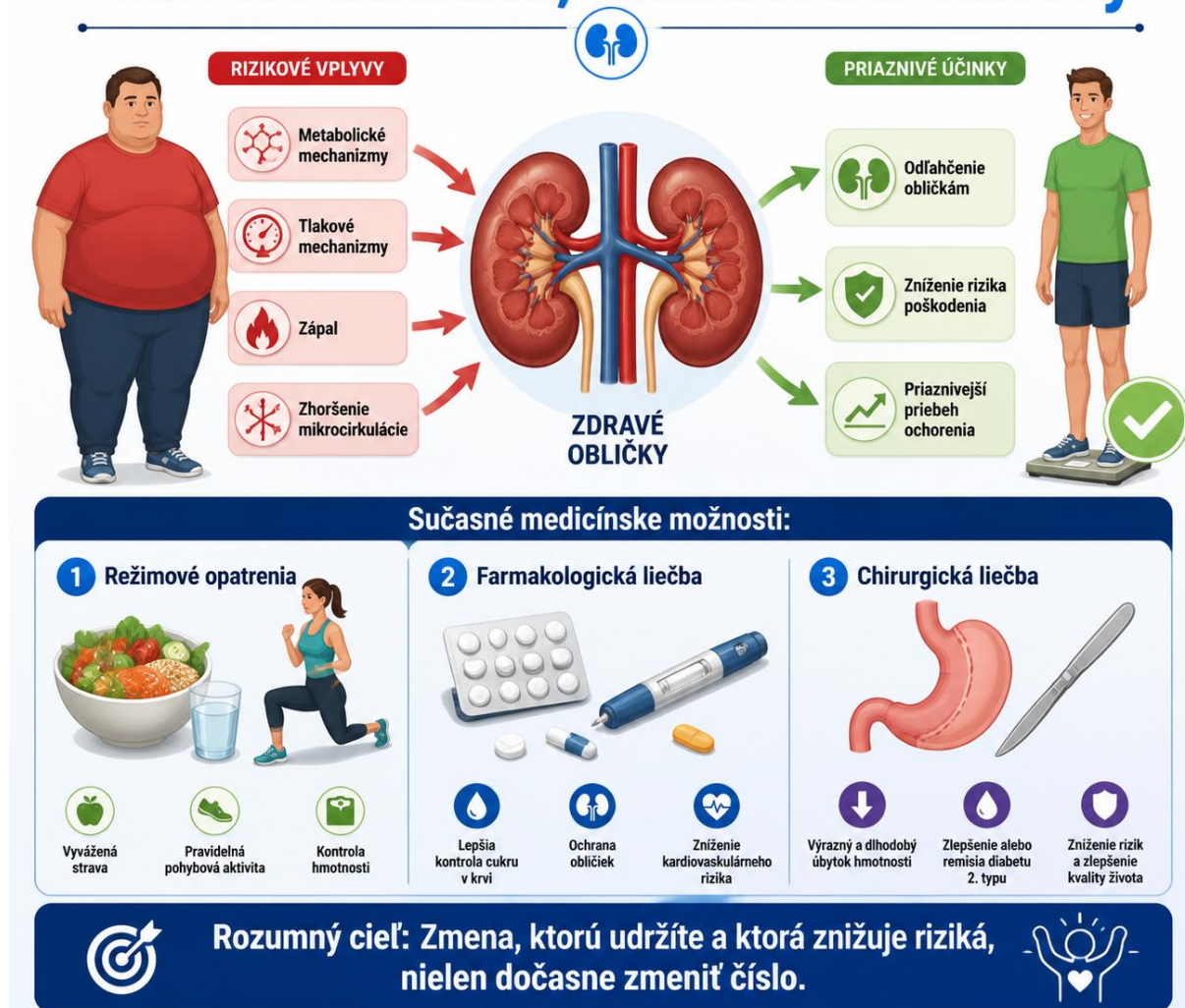


Záver

Obezita zvyšuje riziko poškodenia obličiek u diabetikov najmä prostredníctvom metabolických a tlakových mechanizmov, zápalu a dlhodobého zhoršovania mikrocirkulácie. Redukcia hmotnosti, ak je bezpečná, udržateľná a koordinovaná s liečbou diabetu, môže obličkám reálne odľahčiť a prispieť k priaznivejšiemu priebehu ochorenia.

Súčasná medicína dnes ponúka nielen režimové opatrenia, ale aj farmakologickú liečbu obezity a u vybraných pacientov aj bariatrickú alebo metabolickú chirurgiu. Rozumný cieľ je dosiahnuť zmenu, ktorú viete udržať a ktorá znižuje riziká, nielen dočasne zmeniť číslo.

Záver: Obezita, diabetes a obličky



Autor je nefrológ a internista s rozsiahlymi skúsenosťami v dialyzačnej liečbe, klinickej a preventívnej nefrológii aj v riadení dialyzačných stredísk.

ZDROJE

1. KDIGO. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease [Internet]. 2022 [cited 2026 Jun 20]. Available from: <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/10/KDIGO-2022-Clinical-Practice-Guideline-for-Diabetes-Management-in-CKD.pdf>
2. de Boer IH, Khunti K, Sadusky T, et al. Diabetes management in chronic kidney disease: a consensus report by the ADA and KDIGO [Internet]. Diabetes Care. 2022 [cited 2026 Jun 20]. Available from: <https://kdigo.org/wp->

content/uploads/2018/03/ADA-KDIGO-Consensus-Report-Diabetes-CKD-Diabetes-Care-2022.pdf

3. National Institute for Health and Care Excellence. Semaglutide for managing overweight and obesity. Technology appraisal guidance TA875 [Internet]. London: NICE; 2023 [cited 2026 Jun 20]. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/ta875>
4. Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. N Engl J Med. 2021;384(11):989–1002. Available from: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2032183>
5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Štandardný diagnostický a terapeutický postup pre komplexný manažment nadváhy/obezity v dospelom veku. 2. revízia. Bratislava: MZ SR; 2023 [Internet]. [cited 2026 Jun 20]. Available from: <https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Prevenicia/15-11-2023/SPP-pre-vykon-skriningu-a-prevenicie-preobezity-vo-verejnych-lekarnach.pdf>
6. Zväz diabetikov Slovenska. DiaSpektrum a informácie ZDS [Internet]. [cited 2026 Jun 20]. Available from: <https://zds.sk/>
7. National Kidney Foundation. GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RAs) [Internet]. [cited 2026 Jun 20]. Available from: <https://www.kidney.org/kidney-topics/glp-1-receptor-agonists-glp-1-ras>
8. American Diabetes Association. Chronic kidney disease and risk management: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care. 2024;47(Suppl 1)–S256. Available from: https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S239/157554/11-Chronic-Kidney-Disease-and-Risk-Management
9. Apovian CM, Aronne LJ, Bessesen DH, et al. Pharmacological management of obesity: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(2):342–362. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25590212/>

